RUTA CLÍNICA: INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS - PEDIATRÍA

1. CONCEPTOS IMPORTANTES

CLÍNICA POR EDAD

	+ Frecuente	- Frecuente
LACTANTES <3 MESES	-Fiebre -Vómito -Letargia -Irritabilidad	-Menor tolerancia vía oral -Dolor abdominal -Hematuria -Orina Fétida
>3 MESES PREVERBAL	-Fiebre -Vómito -Menor tolerancia VO	-Irritabilidad, letargia -Dolor abdominal -Hematuria -Orina Fétida
>3 MESES VERBAL	-Polaquiuria -Disuria -Incontinencia -Residuo miccional	-Malestar -Fiebre, vómito -Hematuria -Orina Fétida

Principales Agentes Etiológicos

-Escherichia coli
-Klebsiella pneumoniae
-Enterobacter spp.
-Enterococcus spp.
-Pseudomonas spp.

Factores de Riesgo

-Sexo femenino
-Vaciamiento vesical infrecuente
-Anomalías del tracto urinario
-Reflujo vesicoureteral
-Fimosis
-Disfunción del tracto urinario inferior
-Estreñimiento
-Instrumentación de la vía urinaria
-Contaminación perineal con flora intestinal
-Incontinencia fecal
-Exposición prolongada a heces en los pañales

2. DIAGNÓSTICO

CLÍNICA SEGÚN EDAD

+

NITRITOS + ESTERASA LEUCOCITARIA

POSITIVO

Determinar si requiere manejo hospitalario
-Antibioticoterapia
-Urocultivo

UROCULTIVO
-Punción suprapúbica ≥ 10.000 UFC/ml
-Cateterismo vesico ureteral > 50.000 UFC/ml
-Bolsa urinaria > 100.000 UFC /ml
-Micción espontánea ≥ 100.000 UFC/ml

AJUSTE DE TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO SEGÚN PATRÓN DE RESISTENCIA

NEGATIVO

MICROSCOPIA

POSITIVO

NEGATIVO

Considerar otro diagnóstico

SE PUEDE CONSIDERAR ESTUDIO IMAGENOLÓGICO SI:

1. <2 años primera IVU febril
2. 2-6 años primera IVU febril con respuesta a tratamiento
3. IVU atípica o recurrente
4. Insuficiencia renal
5. Masa abdominal

3. ABORDAJE DEL PACIENTE

Bacteriuria Asíntomática

NO

PARACLÍNICOS + CLÍNICA DE IVU

SI

CLASIFICAR

Localización
- **Baja** → Inflamación de mucosa vesical
- **Alta** → Compromiso de la pelvis y parénquima renal

Complicaciones
- **No Complicada** → Morfología y función renal normal
- **Complicada** →
  -Malformaciones nefro-urológicas
  -Alteración mecánica
  -Falta de respuesta al tratamiento
  -Pielonefritis

Según Episodio
- **Primera Vez** → Evaluar estructuralidad de tracto urinario
- **Persistencia** → Evaluar y ajustar esquema de tratamiento

4.1 TRATAMIENTO EMPÍRICO ORAL

	Tratamiento 1ª línea	Dosis	Tratamiento 2ª línea	Dosis
ITU baja	TMP-SMX	8-10 mg/kg/día cada 12 horas	Amoxicilina-clavulanato	40-45 mg/kg/día cada 8-12 horas
	Nitrofurantoina	5-7 mg/kg/día cada 6 horas		
	Cefalexina	75-100 mg/kg/día cada 6 horas		
ITU baja con factores de riesgo para microorganismos resistentes*	Amoxicilina-clavulanato	40-45 mg/kg/día cada 8-12 horas	TMP-SMX	8-10 mg/kg/día cada 12 horas
ITU Alta	Cefalexina	75-100 mg/kg/día cada 6 horas Dosis máxima: 2000 mg/día		
	Cefuroxima axetil	20-30 mg/kg/día cada 12 horas Dosis máxima: 1 g/día		
	TMP-SMX	8-12 mg/kg/día cada 12 horas		

4.2 TRATAMIENTO EMPÍRICO PARENTERAL

	Tratamiento 1ª línea	Dosis	Tratamiento 2ª línea	Dosis
ITU Baja	Cefazolina	100 mg/kg/día IV cada 6-8 horas	Amikacina*	15 mg/kg/dosis cada 24 horas Dosis máxima: 1000 mg/día
			Gentamicina*	5-7 mg/kg/dosis cada 24 horas Dosis máxima: 2000 mg/día
ITU Alta†	Cefazolina	100-150 mg/kg/día IV cada 8 horas Dosis usual: >30 kg 750 mg IV cada 8 horas	Ceftriaxona	75-100 mg/kg/día cada 24 horas Dosis máxima en ITU: 2 g/día
	Cefuroxima (Zinacef)	Dosis máxima: 1,5 gramos IV cada 8 horas	Amikacina*	15 mg/kg/dosis cada 24 horas
			Gentamicina*	5-7 mg/kg/dosis cada 24 horas
ITU alta con factores de riesgo para microorganismos resistentes o por epidemiología local	Amikacina	15 mg/kg/dosis cada 24 horas	TMP-SMX	8-10 mg/kg/día cada 12 horas
	Cefuroxima‡	100-150 mg/kg/día IV cada 8 horas		

4.3 CRITERIOS PARA TRATAMIENTO PARENTERAL

- Fiebre elevada (≥38,5 oC) en niños de 3 a 6 meses de edad.
- Persistencia de la fiebre posterior a 48 horas de tratamiento indicado.
- Afectación del estado general, aspecto tóxico.
- Vómito o intolerancia a la vía oral.
- Deshidratación y/o mala perfusión periférica.
- Elevación de los reactantes de fase aguda.
- Alteraciones electrolíticas o de la función renal.

Realizado por: Elián Andrés Camacho Zafra - Médico Interno UPTC